

체외충격파(ESWT) 치료 가이드

시행 2026년 7월

근거 보건복지부 보도참고자료(비급여관리정책협의체 제2차 회의, 2026.6.17), 대한의사협회 근골격계 체외충격파 치료 가이드라인

문서 성격

체외충격파는 도수치료와 달리 관리급여가 아니라 **비급여로 유지**됩니다. 7월부터 대한의사협회 **자율 가이드라인**이 시행되며, 강제 고시가 아닌 **자율시정 지침**입니다. 다만 가이드라인을 벗어나면 **실손보험 적용이 제한**될 수 있고, 비급여 가격·사용량은 모니터링 대상입니다.

1 한눈 요약

6회

부위당 최대
(권장)

12회

연간 최대
(권장)

2,000타

1회 최소
(권장)

주 1회

시행 원칙

- **시행 횟수:** 부위당 최대 6회, 연간 최대 12회 권장. **초과 시 실손보험 적용 제외.**
- **적응증:** 아래 7개 부위 질환으로 한정.
- **치료 방법:** 1회 최소 2,000타 이상 권장, 주 1회 원칙, 같은 회차 여러 부위 동시 치료 불인정.
- **비급여 유지**(관리급여 아님). 도수치료(관리급여)와는 별개 항목.
- 가이드라인 밖 적응증은 **의사 판단으로 시행 가능하나 실손 제한 가능하므로 사전 고지 필요.**

2 시행 횟수

- **부위당 최대 6회, 연간 최대 12회.** 횟수 초과 시 실손의료보험 적용에서 제외(금융감독원이 실손 분쟁조정기준에 반영 추진).
- 여기서 부위는 적응증의 **7개 해부학적 부위**(어깨관절·팔꿈치관절·고관절·슬관절·발목관절·족부·척추부). 부위가 다르면 각각 6회로 봅니다(예: 어깨 6회와 족부 6회는 별개).
- **좌·우 양측을 각각 별개 부위로 보는지는 가이드라인 문언에 명시 없음.** 임상에서는 별개로 보는 것이 일반적이거나, 실손 인정은 보험사 심사기준·금융감독원 분쟁조정기준 해석에 따름 [참고].
- 동일 회차(같은 날 1회 시술) 내 **다부위 동시 치료는 불인정. 주 1회 시행이 원칙.**

3 적응증 7개 부위 한정

부위	질환
어깨관절	석회성 건염, 회전근개 건변증
팔꿈치관절	외측상과염, 내측상과염
고관절	대전자 통증 증후군
슬관절	슬개건염
발목관절	아킬레스건염
족부	족저근막염
척추부	경추·요추부 근막통증증후군

적응증 외 시행

상기 적응증 외 질환에 대한 체외충격파는 **의사의 판단으로 시행 가능하나, 실손보험 적용이 제한될 수 있음을 환자에게 사전 고지**해야 합니다.

4 치료 방법

- 1회 기준 최소 2,000타 이상 적용 권장.
- 주 1회 시행 원칙.
- 동일 회차 내 다부위 치료는 불인정.

장비 구분 [참고]

가이드라인은 **집속형·방사형(라디알)** 체외충격파를 대상으로 합니다. 고강도 레이저(힐트) 등 원리가 다른 장비는 **별도 비급여로 분류**되어 본 횟수·기준과 분리됩니다(개별 코드·약관 확인).

5 금기증 시행 금지

- 출혈성 경향이 있거나 **항응고 치료로 출혈 위험이 높은 경우**
- 치료 부위의 **종양(악성·양성 포함)**, 감염 조직, 임신
- **급성 골절, 파열된 건**(회전근개 파열, 아킬레스건 파열 등)
- **18세 미만 성장판 근처 병변, 금속고정물 주위, 폐조직, 뇌, 척수 부위**

6 권고하지 않는 경우

- 골절 불유합·부정유합 상태 / 심혈관 질환 / 피부질환
- 유착성 피막염(오십견) / 무혈성 괴사 / 미상의 건염 등

7 설명 및 동의 치료 전 필수 고지

- 치료 목적 및 기대 효과
- 치료 횟수 및 간격
- 실손보험 적용 여부 및 제한 사항
- 금기증 및 부작용 가능성

특히 강조할 점

가이드라인에 포함되지 않은 적응증은 실손보험 적용이 제한될 수 있음을 명확히 고지해야 합니다.

동의서 양식 [참고]

표준 동의서 양식과 의무 시점은 가이드라인에 규정되어 있지 않습니다. **의료기관·학회 안내를 따릅니다.**

8 도수치료(관리급여)와의 관계

구분	체외충격파	도수치료
급여 성격	비급여 (자율 가이드라인)	관리급여 (본인부담 95%)
횟수 기준	부위당 6회·연 12회 권장	주 2회·연 15회(예외 24회)
가격	병원 자율 (비급여)	1회 43,850원 (전국 동일)

- 도수치료와 비급여 체외충격파를 같은 날 병행하는 것은 **현행 법체계상 별도 제한 없으나**, 전문학회 가이드라인 준수를 권고하며 **동시 시술은 별도 모니터링 예정** (도수치료 질의응답 Q8).

선행치료 불인정 (핵심)

체외충격파는 도수치료의 **선행치료(이학요법로 제1절 기본물리치료료·제2절 단순재활치료료, 2주·4회)로 인정되지 않습니다.** (보건복지부 고시 제2026-136호 도수치료 급여기준 목록, 질의응답 Q18)

9 환자 안내

- 환자에게 전달할 내용(비용·횟수·적응증·실손·치료 전 설명)은 별도 문서 **「현장정리본_체외충격파_환자용」** 참고.

10 근거·출처

- 보건복지부 보도참고자료 「체외충격파 의료기관 자율 가이드라인 7월부터 시행」 (비급여관리정책협의체 제2차 회의, 2026.6.17).
- 대한의사협회 근골격계 체외충격파 치료 가이드라인(대한의사협회 안내 및 홈페이지 공지 예정).
- 보건복지부 고시 제2026-136호 도수치료 급여기준 목록; 도수치료 관리급여 질의응답(2026.6.29) Q8·Q18.